患者视角 · 科普资料汇编

抑郁症资料库

模块内容与延伸专题

阅读提示：本资料仅供学习科普，不能替代精神科专业评估、诊断或处方。请勿据此自行增减或停用药物；遇到迫切安全风险，请联系当地急救或急诊服务。

目录

资料库总目录

目录

模块1：基础定义与疾病概况

1. 疾病正式名称

2. 疾病本质

3. 流行病学

4. 名词释义

5. 常见合并情况

模块2：临床表现

1. 核心症状

2. 附加症状

3. 不同亚型特点

4. 疾病分期

模块3：病因与诱发因素

1. 生物学因素

2. 心理因素

3. 环境诱因

4. 常见误区澄清

5. 诱发复发的常见触发事件

模块4：就医、评估与诊断

1. 就诊渠道

2. 就诊准备

3. 医生诊断流程

4. 常用自评量表说明

5. 鉴别诊断

模块5：治疗方案

5.1 药物治疗

5.2 心理治疗

5.3 物理治疗

模块6：自我康复、复发管理与危机干预

1. 复发预警信号

2. 日常自我照顾策略

3. 负性思维觉察与调整

4. 危机识别与急救

5. 社会支持

模块7：误区、权益与资源

1. 常见误区澄清

2. 生活与权益

3. 正规书籍与科普资源

4. 偏方与网络疗法风险

可选附加模块

共病专题

家属参考附录

康复者视角

抑郁症资料库（面向患者视角）

> 前置免责声明：本资料库仅作学习科普，**不能替代精神科医生面诊、诊断与处方**。不可自行依据资料判断病情、增减或停用药物。所有内容标注来源，区分临床共识、研究结论、个人体验、争议观点。

整体分为 **7大模块**，内容偏向患者视角，聚焦自我识别、就医、治疗、日常康复、危机应对。

模块1：基础定义与疾病概况

核心：帮患者理解疾病，破除误区

1. 疾病正式名称

- 中文：抑郁障碍（重性抑郁障碍 / 抑郁症），英文 Major Depressive Disorder（MDD）
- ICD-11、DSM-5 编码与命名说明
- 区分：抑郁情绪 vs 抑郁症（一过性心情不好≠疾病）

1. 疾病本质：大脑神经递质、神经可塑性、遗传、环境共同作用的疾病，**不是单纯“想不开、矫情、意志力差”**
2. 流行病学：发病年龄、男女发病特点、复发概率
3. 名词释义：单次发作/反复发作、持续性抑郁障碍（恶劣心境）、季节性抑郁、伴精神病性症状抑郁
4. 常见合并情况：常和焦虑、失眠、躯体不适共病

模块2：临床表现（患者自我觉察为主）

> 从患者感受角度描述，避免生硬教科书式表述

1. 核心症状（2条核心）

- 持续情绪低落、悲伤、空虚，快感缺失（对原本喜欢的事提不起兴趣）

1. 附加症状

- 认知：注意力下降、记忆力变差、自责、无价值感、悲观、思维迟缓
- 躯体：睡眠紊乱（失眠/嗜睡）、食欲体重变化、乏力、疼痛、肠胃不适、性欲下降
- 行为：行动变慢、不愿社交、拖延、自我封闭

1. 不同亚型特点

- 伴有焦虑痛苦的抑郁
- 伴有精神病性症状的抑郁（幻觉、妄想）
- 非典型抑郁（嗜睡、暴食、肢体沉重）
- 季节性抑郁
- 持续性抑郁障碍（长期轻度低落，持续2年以上）

1. 疾病分期：发作期、巩固期、维持期、缓解期

模块3：病因与诱发因素（患者视角：理解为什么会发病）

1. 生物学因素：遗传易感性、神经递质、脑区功能变化、激素（甲状腺、性激素、皮质醇）
2. 心理因素：长期负性思维模式、完美主义、早年创伤
3. 环境诱因：重大丧失、长期压力、孤独、冲突、失业、生病、睡眠长期剥夺
4. 澄清误区：**不是性格软弱造成；只是风险因素叠加，不是单一原因**
5. 诱发复发的常见触发事件（方便患者自我留意）

模块4：就医、评估与诊断

> 重点告诉患者：去哪里就诊、会经历什么，减少就医恐惧

1. 就诊渠道：精神卫生中心、综合医院精神科/心理科；不推荐单纯心理咨询做诊断
2. 就诊准备：就诊前可以提前整理的信息清单（症状时长、睡眠饮食、既往病史、家族史、用药史）
3. 医生诊断流程：精神检查、躯体排查（抽血、甲状腺等，排除躯体疾病引发抑郁）
4. 常用自评量表说明：PHQ-9、SDS、汉密尔顿抑郁量表HAMD

> 重要备注：自评量表**仅筛查，不能作为确诊依据**

1. 鉴别：哪些情况看起来像抑郁但不是（甲状腺疾病、维生素缺乏、脑器质性病变、药物副作用、双相情感障碍）

模块5：治疗方案（患者最关心，循证科普）

5.1 药物治疗

- 抗抑郁药类别简介（SSRI、SNRI、NaSSA等）

- 起效特点：**不是立刻见效，通常2–4周才逐步起效**
- 常见早期副作用，区分短期不适与危险不良反应
- 用药原则：足量足疗程；不要自行突然停药（撤药反应、复发风险）
- 换药、合并用药的适用场景
- 禁忌与注意事项（严禁和部分药物、违禁物质混用）

5.2 心理治疗

- 一线推荐：认知行为疗法CBT、正念认知疗法MBCT（预防复发）
- 其他：IPT人际关系治疗、支持性心理治疗
- 说明：中度重度抑郁，**优先药物+心理联合**；轻度可单用心理治疗

5.3 物理治疗

- 无抽搐电休克 MECT：适用场景，适合重度、有自伤拒食、难治性抑郁；打消恐惧误区
- rTMS重复经颅磁刺激，适用范围

模块6：自我康复、复发管理与危机干预（患者实操模块）

1. 复发预警信号清单（患者可以自我监测）

- 睡眠改变、兴趣下降、消极想法增多、体力持续变差、情绪持续走低

1. 日常自我照顾策略

- 睡眠管理、运动建议、饮食、社交最低限度维持、压力减负
- 正念、情绪记录、情绪日记（简单可落地）

1. 负性思维觉察与调整（简化版CBT，适合日常练习）
2. 危机识别与急救

- 自伤、自杀念头分级：想法、计划、准备、行动
- 紧急求助渠道、如何联系身边支持者、住院指征
- 安全计划模板（可直接保存使用）

1. 社会支持：如何和家人沟通病情，如何向亲友表达需求

模块7：误区、权益与资源

1. 常见误区澄清

- “想开点就好了”“吃药会变傻上瘾”“抑郁症就是矫情”“好了就可以立刻停药”

1. 生活与权益：病假、医保、心理援助热线、残疾相关政策参考
2. 适合患者的正规书籍、科普资源
3. 禁忌提醒：偏方、保健品、网络“抑郁自愈疗法”风险

可选附加模块（按需增加）

- 【共病专题】抑郁合并焦虑、睡眠障碍、躯体疼痛、物质滥用；区分双相情感障碍（极易误诊为抑郁）
- 【康复者视角】康复体验（注明仅个人感受，不代表所有人）
- 【家属参考附录】：家属该怎么陪伴、哪些话不要说（放在附录，主体面向患者）

资料库首页两条核心规则

1. 免责声明：资料库仅科普学习，**不可作为诊断、用药依据，出现症状请前往正规精神科就诊。**
2. 来源标注原则：关键内容标注来源，区分临床指南、综述、个案体验，过滤网络传言。

1. 疾病正式名称

> 本页用于解释常见名称和分类系统。诊断名称、编码及本地实施方式可能随分类版本和地区政策变化；个人病历应以接诊机构采用的分类版本为准。

1.1 常见中文与英文名称

- **抑郁障碍**：一组以持续抑郁情绪、兴趣或愉悦感下降等为主要表现的精神障碍的总称。
- **重性抑郁障碍（Major Depressive Disorder, MDD）**：DSM-5/DSM-5-TR 中的诊断名称之一，中文日常常称“抑郁症”。
- **抑郁症**：常见俗称和科普用语，不一定对应某一套分类中的单一正式诊断名称。就诊或填写医疗资料时宜使用病历上的具体诊断。

1.2 ICD-11 与 DSM-5 的命名差异

世界卫生组织的 **ICD-11** 将相关诊断置于抑郁障碍类别中，包括“单次发作性抑郁障碍”（6A70）和“复发性抑郁障碍”（6A71）等分类，并可按临床特征进一步描述。ICD 是国际健康信息记录和疾病统计的重要分类系统。

美国精神医学学会的 **DSM-5/DSM-5-TR** 使用“重性抑郁障碍”（Major Depressive Disorder）这一名称，并按单次/复发、严重程度、缓解状态及特征说明等记录。DSM 版本和当地编码转换可能影响编码呈现，因此本文不将一串 DSM 编码作为个人诊断依据。

两套分类在术语、条目和编码用途上并非完全相同。面向公众的资料应注明采用哪一套分类及版本，避免把 ICD 与 DSM 的名称当作完全可互换。

1.3 “抑郁情绪”不等于“抑郁障碍”

人在失落、压力或疲惫时出现低落情绪很常见。临床诊断还会关注症状是否持续、是否伴随兴趣下降或其他认知/躯体改变、是否造成明显痛苦或生活功能受损，以及能否由其他疾病、物质或药物解释。

所以，难过几天不自动表示患有抑郁障碍；反过来，患者也不一定总是哭泣或能清楚描述“悲伤”。诊断需由专业人员综合访谈与病程作出，而不是凭标签、单一症状或量表分数。

1.4 使用名称时的尊重原则

使用“抑郁障碍患者”或“正在经历抑郁的人”等中性表达，避免用“矫情”“脆弱”概括一个人。诊断名称是医疗沟通工具，不能代表一个人的全部身份、能力或未来。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- American Psychiatric Association：DSM

2. 疾病本质

2.1 什么是抑郁障碍

抑郁障碍是一类以持续的情绪、兴趣、思维、身体状态和日常功能变化为特征的精神健康问题。它不只是暂时“不开心”，也不代表一个人意志薄弱或不够努力。不同患者的体验、严重程度、持续时间和恢复过程都可能不同。

抑郁症状会影响睡眠、食欲、精力、专注、决策、人际关系和学习工作。有些人主要感到悲伤或空虚，有些人更明显地体验到麻木、疲惫、易怒、身体不适或失去兴趣。

2.2 多因素共同参与

研究提示遗传易感性、脑功能与神经可塑性、身体健康、心理过程、生活经历和社会环境等因素可能相互影响。某些神经递质和脑网络参与情绪调节，但目前不能把抑郁简单说成某一种物质“太少”，也没有单一检查可以确定每个人的病因。

相同的压力不会让所有人患病；不少患者也找不到一个明确触发事件。病因尚未完全阐明，不意味着疾病不真实，而是说明其机制复杂，尚不能用单一故事解释所有人的经历。

2.3 不是“想开点”就能控制

鼓励和陪伴有价值，但抑郁障碍不是靠责备、劝说或强迫积极思考即可解决。患者可能很难启动活动、集中注意或感受到希望，这些困难不应被解释为懒惰或不配合。适当的医疗照护、心理治疗、社会支持和身体健康管理可以成为恢复计划的一部分。

2.4 病程与恢复

抑郁可能呈单次发作、反复发作或持续症状等不同轨迹。多数情况下可以获得有效帮助，但恢复速度和程度因人而异；症状缓解、恢复功能和重新建立生活节奏可能不是同时发生的。

“恢复”可以包括睡眠和精力改善、重新参与关系和活动、重建学习工作能力，也包括学会识别预警信号和获得所需支持。治疗目标应由患者与专业人员共同商定。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

3. 流行病学

> 流行病学描述人群统计规律，不用于判断个人是否患病或预测某个人的结局。不同国家、调查年份、诊断标准和调查方式会影响数字。

3.1 全球患病情况

世界卫生组织指出，抑郁是常见的精神障碍，全球各年龄段均可能受到影响。WHO 的抑郁症事实清单提供全球估计值，并报告女性受影响比例高于男性。全球估计不能直接替代中国本地调查，也不表示任何性别或年龄组必然患病。

患病率会随时间范围而不同：某一时点患病比例、过去一年患病比例和一生中曾患病比例不是同一个指标。阅读数字时应检查研究对象、调查年份、诊断方法和统计口径。

3.2 发病年龄与性别差异

抑郁症状可在儿童、青少年、成年人和老年人中出现，但不同年龄阶段的表现、求助方式和评估重点可能不同。儿童青少年可能更多表现为易怒、退缩、学习或睡眠变化；老年人也可能同时有身体疾病、药物影响或认知问题需要评估。

研究总体上发现女性被报告或诊断为抑郁的比例较高，但这不能说明男性不会患病。表达方式、求助意愿、社会角色、医疗服务可及性和筛查差异都可能影响统计。群体性别差异不能用来判断某个人。

3.3 复发与病程

抑郁可能只发生一次，也可能出现复发或较长期症状。复发率会受到随访年限、研究人群、复发定义、既往发作次数、治疗和社会环境等影响。没有明确研究条件的单一百分比容易造成误导。

个人未来病程无法仅凭流行病学数字预测。既往发作、未完全缓解的症状、身体和心理社会状况、治疗可及性等都值得与专业人员讨论。

3.4 阅读统计时的提醒

- 分清患病率、发病率、首次发作和复发率。
- 核对数据所属地区、年份、年龄范围和诊断系统。
- 统计关联不等于个人因果，也不代表每位患者经历相同。

- 不把性别、年龄、职业或社会身份用于给个人贴标签。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- 世界卫生组织：Mental health data and statistics

4. 名词释义

> 诊断术语因 ICD、DSM 及其版本而异。以下解释用于阅读资料，不应用来自行判断。

单次发作与复发性抑郁障碍

- **单次发作**：目前或既往记录中符合一次抑郁发作的病程描述。
- **复发性抑郁障碍**：既往曾有抑郁发作，之后又出现新的发作；分类系统对发作间隔和缓解的具体要求不同。

复发不是患者的失败，也不能单凭再次低落就确认；需评估症状、时间线和其他原因。

持续性抑郁障碍

持续性抑郁障碍指较长期的抑郁情绪或相关症状。旧资料中的“恶劣心境/心境恶劣障碍”是历史术语，在现行分类中具体名称和标准可能已调整。持续时间和严重程度需要按使用的诊断系统判断，不应仅因“低落很久”自行确诊。

季节性模式

“伴季节性模式”通常指抑郁发作与特定季节有规律的时间关联，并在其他季节缓解。单次冬季心情差或天气影响情绪，不足以诊断季节性模式。需评估多年的时间规律、症状和功能影响。

伴精神病性症状的抑郁

严重抑郁发作有时可伴幻觉或妄想等精神病性症状。出现这类体验需要尽快专业评估，同时排查其他精神障碍、身体或物质相关原因。此类症状不等同于精神分裂症，诊断需结合整个病程。

缓解与残余症状

缓解表示症状显著减轻或不再达到某一诊断发作标准，但仍可能有残余困难。缓解不意味着可以自行停药或停止随访；治疗计划应和专业人员共同决定。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

5. 常见合并情况

抑郁障碍可能与其他精神或身体健康问题同时出现。共病会影响症状、生活功能和治疗计划，因此就诊时应尽可能告知医生完整情况。

焦虑问题

担忧、紧张、恐慌或回避可能与抑郁同时出现。焦虑会影响睡眠、专注和日常活动，也可能需要独立评估和支持。持续焦虑不代表患者“想太多”或故意夸大。

睡眠问题

入睡困难、夜间醒来、早醒或嗜睡都可能伴随抑郁出现；睡眠障碍也可能加重白天疲惫和情绪波动。睡眠变化还可能与药物、疼痛、呼吸问题、作息或其他身体疾病有关。

躯体不适

头痛、肌肉疼痛、胃肠不适、心悸或乏力可能与抑郁同时存在，但不能因此假定症状“只是心理作用”。新出现、严重或持续的身体不适应按需要进行医学评估。

物质使用和其他精神障碍

酒精或其他物质可能被用于应对痛苦，也可能加重情绪、睡眠和治疗风险。双相情感障碍、创伤相关问题和其他精神障碍也可能与抑郁症状重叠，需要了解完整病程。

就诊时可提供的信息

说明症状开始时间、睡眠和疼痛情况、正在使用的药物或补充剂、酒精及其他物质使用、既往情绪高涨或异常精力增加经历。准确告知有助于医生鉴别和制定安全计划，不是接受道德评判。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

1. 核心症状

> 本页帮助描述可能的抑郁体验，不是自我诊断表。症状是否构成抑郁障碍，需由专业人员结合持续时间、其他表现和功能影响评估。

情绪低落

可能表现为持续悲伤、空虚、沉重、麻木、易哭或易怒。有些人说不清“难过”，只觉得每天都很费力、没有盼头，或对周围事物失去反应。低落不一定整天以同一种形式出现，也不要求患者必须哭泣。

兴趣或愉悦感下降

以前喜欢的爱好、与朋友相处、音乐、美食或亲密关系可能变得索然无味。患者可能知道某件事过去重要，却很难感到期待或满足。这不是不珍惜别人，也不必然表示兴趣永久消失。

持续时间和影响

临床分类通常要求核心情绪/兴趣变化持续一段时间，并同时存在其他症状和显著痛苦或功能受损；常见诊断标准会评估约两周或更长时间，但具体诊断不能只靠时长判断。短期情绪低落值得关心，若持续、加重或影响生活，也可以求助，不必等到“足够严重”才就医。

个体差异与求助

抑郁可表现为低落、麻木、烦躁、疲惫或身体不适；外表看起来正常也不能排除痛苦。若有伤害自己的想法、无法保证安全或症状迅速恶化，应立即告诉可信任的人并联系当地急救/精神卫生服务。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

2. 附加症状

抑郁障碍除情绪低落或兴趣下降外，还可能影响思维、身体感受和行为。并非每位患者都会有全部症状，表现也可能随时间变化。

认知与自我评价

- 专注、记忆和做决定变困难；
- 思考或说话感觉变慢，处理日常任务需要更多精力；
- 反复自责、无价值感、过度内疚或对未来悲观；
- 思维反复围绕失败、损失或担忧打转。

这些体验会让患者难以启动任务，但不等同于智力下降或缺乏努力。

躯体与生理变化

可能出现失眠、早醒或嗜睡；食欲和体重增加或下降；疲惫、精力不足；头痛、肌肉疼痛、胃肠不适；性欲变化等。身体症状真实存在，应向医生描述，不要自动归为“心理作用”。药物、内科疾病和生活作息也可能造成类似变化。

行为与功能

患者可能减少社交、延迟回复消息、缺课缺勤、难以完成家务或个人照护，或行动和言语明显变慢。有时外人会误解为懒惰或不在乎；更有效的支持是询问具体困难、提供可接受的小帮助。

需要特别关注的信号

强烈绝望、反复想到死亡、自伤或自杀念头需要认真对待。若存在计划、准备行为、已经行动或无法保证安全，应立即联系当地急救/急诊服务，并让可信任的人陪伴。不要只用量表分数判断风险。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- 世界卫生组织：Suicide fact sheet

3. 不同特征与临床说明

> “亚型”“特征说明”依 ICD、DSM 及版本而异。以下内容用于理解临床描述，不代表自我分类；出现某一特征也不自动确定诊断。

伴焦虑痛苦特征

抑郁发作可能同时伴随明显紧张、坐立不安、担心失控或难以集中注意。焦虑程度可能影响痛苦和治疗计划，需单独告诉医生。

伴精神病性症状

严重抑郁有时会出现幻觉或妄想等体验。若发生，应尽快由专业人员评估；这不等同于精神分裂症，且可能需要更紧急和综合的治疗安排。若有迫切安全风险，应联系急救/急诊。

非典型特征

部分分类系统使用“非典型特征”描述某些症状组合，例如情绪对积极事件暂时有所反应、食欲增加或嗜睡、肢体沉重感及对人际拒绝较敏感。单一症状如嗜睡或食欲变化不足以确认此特征。

季节性模式

季节性模式需有规律的发作与季节关系及相应病程证据，不等同于冬天偶尔情绪低落。可记录数年情绪、睡眠和活动变化，交由医生综合判断。

持续性抑郁障碍

表现为长期持续的抑郁情绪或相关症状，可能程度较轻但长期影响生活，也可能与较重的抑郁发作并存。旧称“恶劣心境”在不同分类版本中含义和使用方式不同，应以现行诊断系统为准。

参考来源

- 世界卫生组织：ICD-11 浏览器
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

4. 病程阶段与治疗阶段

“发作期、巩固期、维持期、缓解期”是描述症状变化和照护目标的常用术语，并非每个人都严格按固定顺序经历。阶段定义和持续时间应以专业人员采用的指南与分类为准。

发作期

抑郁症状达到明显程度并影响情绪、身体状态或生活功能时，临床会评估症状、风险、共病和适合的治疗。症状可能逐步出现，也可能在压力或健康变化后加重。

巩固期

症状开始改善后，仍需维持治疗和随访，以巩固获益、处理副作用、恢复活动和功能。此阶段不要因为“好了一点”就自行停药或中断心理治疗。

维持期

部分患者因既往病程、复发风险或其他因素需要更长期的支持和复诊。是否、何时以及如何继续治疗由患者与专业人员共同讨论，不能由统一时长适用于所有人。

缓解与复发

缓解指症状显著减轻或暂时不再达到发作标准，但可能仍有残余症状或生活困难。复发指缓解后症状再次达到临床关注程度；仅有一两天情绪波动不等于复发。

个体化管理

可与治疗团队记录个人早期变化、有效的应对方式、联系渠道和复诊计划。若出现自伤/自杀风险或快速恶化，应优先求助，不等待阶段判定。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单

1. 生物学因素

> 抑郁障碍没有一个能解释所有人的单一生物学原因。多数发现反映群体层面的风险或相关性，不能通过某个化验、基因或脑扫描确定个人病因。

遗传易感性

家族和双生子研究提示遗传差异会影响风险，但并非单基因遗传。遗传易感性不等于命运，也不意味着父母患病子女必然患病。家族中共享的环境和生活经历也可能参与关联。

神经递质、脑网络与神经可塑性

血清素、去甲肾上腺素、多巴胺等神经递质以及情绪调节、奖赏和压力反应相关脑网络都在研究中。抗抑郁药影响某些神经递质系统，但药物作用机制不能简化成“抑郁就是某种物质不足”。神经可塑性和学习、压力适应等过程可能参与症状和恢复，具体机制仍在研究。

激素与身体健康

甲状腺功能异常、某些内分泌变化、慢性炎症、睡眠问题和其他身体疾病可能与情绪症状相互影响。皮质醇、性激素等生理指标在研究中受到关注，但不能仅凭一次激素检测诊断抑郁或决定治疗。

临床意义

医生会根据症状、病史和体征决定是否需要检查甲状腺或其他身体状况。除非有临床指征，不应自行购买激素或神经递质检测，也不应以“脑化学不平衡”解释每个人的经历。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- National Institute of Mental Health：Depression

2. 心理因素

心理过程可能影响一个人如何体验压力、理解事件和应对困难，但不能据此把抑郁归咎于患者。不存在某种“坏性格”必然导致抑郁的简单规律。

负性思维与反刍

在抑郁状态下，有些人容易反复回想失败、责备自己、只注意负面证据或难以想象未来会改善。这些思维可能既是痛苦的一部分，也会进一步影响情绪和行为；它们并非故意选择，也不是“只要想开点”就能消失。

完美主义与自我要求

过高或僵化的标准、害怕犯错、把自我价值完全系于成绩或他人认可，可能增加压力或维持痛苦。完美主义不是疾病诊断，也不代表它单独造成抑郁；具体影响因人而异。

早期经历与创伤

童年逆境、欺凌、忽视、暴力或重大丧失与后续心理健康问题存在研究关联。关联不证明每个经历创伤的人都会抑郁，也不能由抑郁诊断推断某人一定经历过创伤。谈及创伤应尊重当事人的节奏、隐私和选择。

心理治疗的作用

认知行为治疗、人际关系治疗等可帮助患者理解思维、情绪、行为和关系中的模式，练习新的应对方式。治疗不是证明患者“想错了”，也不要求否认现实困难；目标应结合本人需要共同设定。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单

3. 环境诱因

> 生活事件可能与抑郁症状开始或加重有关，但相关不等于确定因果。许多经历同类事件的人不会患抑郁，许多患者也找不到单一明确诱因。

可能增加压力的经历

- 亲友离世、关系结束或其他重大丧失；
- 长期照护、工作学业压力、经济困难或失业；
- 人际冲突、孤独、歧视、欺凌或社会排斥；
- 慢性疾病、疼痛、重大手术或家庭成员患病；
- 长期睡眠不足、作息紊乱或缺少恢复时间；
- 居住不稳定、迁移或其他生活环境变化。

这些情境可能和身体健康、既往经历、支持资源等共同影响情绪。环境因素不应被简化为“想太多”，也不应成为责怪患者或家属的理由。

睡眠和日常节律

长期睡眠紊乱会影响精力、专注和情绪；抑郁本身也可能改变睡眠。睡眠变化既可能是风险背景，也可能是症状表现，不能单独作为病因证明。

寻找个人模式而非寻找“罪魁祸首”

对患者有帮助的做法，是与治疗人员一起观察哪些环境变化与症状同时出现、哪些支持能减轻负担，并寻找现实可行的调整（例如减轻短期任务、增加支持、处理疼痛或改善睡眠）。记录模式不代表能准确预测发作，也不需要强迫自己找出唯一原因。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

4. 常见误区澄清

抑郁不是性格软弱

患抑郁障碍不代表缺少意志、矫情或不够坚强。症状会真实影响睡眠、精力、注意、动机和生活功能。对患者说“你只要努力就行”可能让其感到被责备，而不是得到帮助。

不存在唯一、普遍的病因

遗传易感性、身体和脑功能、心理过程、生活事件与社会环境可能共同参与。某个压力事件、家庭关系或生物指标不能解释所有病例，也不能证明个人是“自己造成的”。

风险因素不是必然结果

家族史、创伤或压力可能与统计风险有关，但并非充分条件。相同经历对不同人的影响不同。风险因素研究不能用于判定某人将来一定患病。

患病不是患者或家属的过错

把病因归咎于父母、教养方式或患者选择既缺乏依据，也可能增加羞耻和延迟求助。关注可获得的治疗、支持和安全比追究责任更有帮助。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- 世界卫生组织：Mental health

5. 可能与复发或症状加重相关的变化

> “触发因素”是个人回顾中发现的时间关联，不等同于医学上已证实的单一原因。记录用于提前安排支持，不用于自责或预测命运。

值得与专业人员讨论的变化

- 连续睡眠不足、作息大幅改变或长期超负荷；
- 亲友离世、关系变化、冲突或孤独感增加；
- 失业、学业压力、经济或住房困难；
- 身体疾病、疼痛、激素或其他健康状况变化；
- 酒精或其他物质使用变化；
- 药物副作用、漏服或治疗计划变化；
- 既往熟悉的低落、兴趣下降、疲惫或自责重新加重。

同一事件可能同时影响睡眠、关系和身体健康；有时症状本身也会改变生活处境，因果方向并不容易判断。

如何制作个人记录

可简要记下日期、睡眠、情绪/兴趣、精力、日常功能、重大事件、药物变化和采取的支持。使用简单记录即可，不必全天监测或追求精确分数。如果记录让焦虑加重，可暂停并与治疗人员讨论。

应对原则

当发现持续变化时，尽早联系治疗团队，讨论是否需要复诊、支持或治疗调整。不要因认为“是自己没处理好压力”而隐瞒，也不要自行停药、加药或使用保健品替代处方。

若出现自伤/自杀想法并伴有计划、准备或无法保证安全，应立即联系急救/急诊或当地危机服务，而非仅依靠记录观察。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单

1. 就诊渠道

如果情绪、兴趣、睡眠、精力或日常功能持续受到影响，可以尽早寻求专业评估；不需要等到无法工作或生活才求助。

可考虑的正规渠道

- 精神卫生中心或精神专科医院的精神科；
- 综合医院精神科；部分医院设有心理科或心身医学科；
- 当地卫生健康部门公布的正规心理健康服务。

具体科室名称、预约方式和服务范围因地区而异。查看医院官方平台，确认接诊范围、费用和是否需要转诊。首次就诊可说明自己不确定该挂哪个科，请医院导诊协助。

心理咨询与医疗诊断

心理咨询师可提供心理支持或心理治疗，但资格和执业范围因地区、机构而异；医疗诊断、身体排查和处方应由具备相应资质的医疗专业人员完成。仅接受单纯心理咨询而没有合适医疗评估，可能遗漏双相障碍、身体疾病、药物影响或安全风险。

如果担心就医

可请可信任的人陪同、提前写下想说的内容，或在预约时询问隐私保护和首次就诊流程。专业人员需要了解症状并非为了评判你。若存在迫切自伤风险、严重意识改变或无法保证安全，应直接联系当地急救/急诊服务，不等待普通预约。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- 国家卫生健康委：心理健康和精神卫生相关信息

2. 就诊准备

准备资料不是就诊的前提。如果正在经历严重痛苦或有即时安全风险，请先寻求帮助，不必等材料整理齐全。

可提前记录的内容

- 症状大约何时开始，持续多久，最近是否加重或缓解；
- 情绪、兴趣、睡眠、食欲、精力、专注和日常功能的变化；
- 是否出现过自伤/自杀想法，及目前最担心的安全问题；
- 既往精神和身体健康情况、家族相关病史（知道多少写多少）；
- 目前和近期使用的处方药、非处方药、保健品及剂量（可带药盒/清单）；
- 酒精或其他物质使用情况，如适用；
- 既往治疗、心理咨询、住院或药物反应；
- 希望从就诊中获得什么帮助，最想问医生的问题。

不需要用专业术语或写成完整报告，简单例子就有用，例如“过去三周大多数早晨都很难起床，已经连续缺课”。

是否带家属

患者可自行决定是否邀请可信任的人陪同。经本人同意，陪同者可以补充时间线或帮助记住建议；患者也可以要求单独与医生交谈。家属信息不能替代患者表达，隐私与安全应受到尊重。

就诊时可以询问

- 目前有哪些可能的解释，是否需要排查身体原因？
- 哪些情况需要紧急联系医院？
- 若建议治疗，预期获益、风险、替代方案和复诊时间是什么？
- 如何联系治疗团队，如何保护隐私？

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：mhGAP guideline

3. 医生诊断流程

> 实际流程依症状、年龄、病史和医疗机构而异。并非每个人都需要同一套化验或影像检查。

3.1 了解症状和生活影响

医生会询问低落、兴趣、睡眠、食欲、精力、注意力、自我评价、绝望感等变化及其持续时间，也会了解这些变化如何影响学习、工作、人际关系和自我照顾。可能询问自伤/自杀想法，以评估是否需要立即安全支持；如被问到，可尽可能如实回答。

3.2 了解既往病程与治疗

评估可能包括过去是否有类似发作、异常兴奋或精力明显升高时期、家族史、身体疾病、既往治疗效果和副作用、处方药及其他物质使用。双相情感障碍、药物影响和物质相关症状需要特别鉴别。

3.3 身体检查与辅助检查

医生可能进行体格检查，并根据病史决定是否查甲状腺功能、血液指标或其他身体状况，以排除或发现可能导致相似症状的原因。没有某项血液、激素、脑影像或神经递质检查可以单独确诊抑郁障碍。

3.4 形成诊断和计划

医生结合症状、持续时间、功能受损、病史和排除因素形成临床判断。有时首次就诊资料不完整，可能先记录初步判断并安排随访。诊断不是对人格或未来的评价；患者可以询问判断依据和治疗选择。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）

4. 常用自评与临床评定量表

> 量表用于筛查、描述症状或观察一段时间内的变化，**不能单独确诊抑郁障碍，也不能替代自杀风险评估。**分数应结合访谈、病史和功能情况解释。

PHQ-9

患者健康问卷-9（PHQ-9）询问过去两周内若干抑郁相关体验的频率，常用于初步筛查和症状追踪。某些版本含有关于死亡或自伤念头的项目；任何相关回答都需要进一步、直接的专业评估，不能只看总分。

SDS

抑郁自评量表（SDS，Self-Rating Depression Scale）由填写者报告自身近期感受。不同语言版本、评分换算和使用场景可能不同；网络上流传的分界值不一定适合所有人。

HAMD

汉密尔顿抑郁量表（HAMD/HDRS）通常由经过培训的评估者通过访谈和观察评分，可用于评估症状严重程度或研究疗效。它不是患者自我诊断问卷，不同版本和项目数也不相同。

正确使用方式

- 答题时按量表说明的回顾时间和实际体验作答，不为“得到某个结果”修改答案。
- 分数高低不能证明具体病因或自动决定用药。
- 复测时记录日期和变化，向医生说明分数之外的实际生活困难。
- 若量表提示自伤/自杀想法或本人感到不安全，直接联系专业人员或急救服务，不要等待复测。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- Kroenke K, Spitzer RL, Williams JBW. **The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure.** *Journal of General Internal Medicine*. 2001;16:606–613. doi:10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x

- Hamilton M. **A rating scale for depression.** *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*. 1960;23:56–62.

5. 鉴别诊断

情绪低落、疲劳、睡眠和注意力变化可以由多种精神或身体状况造成。鉴别诊断不是否认患者的痛苦，而是寻找更准确、也更安全的解释。

双相情感障碍

医生会询问既往是否出现过与平时明显不同的情绪高涨或易怒、精力增加、睡眠需求减少、话多、思维加快、冲动或冒险行为等时期。患者未必把这些经历视为问题，因此完整时间线和知情者补充（经本人同意）可能有帮助。不能仅凭一次情绪好转确认双相障碍。

甲状腺及其他身体状况

甲状腺功能异常、贫血、慢性疼痛、睡眠呼吸问题、感染、神经系统或其他身体疾病可能出现疲劳、情绪或认知变化。医生会根据症状、体征和病史决定是否检查；不是每位患者都需要所有化验。

药物与物质影响

某些处方药、非处方药、补充剂、酒精或其他物质可能影响情绪、睡眠和精力。告知医生实际使用情况有助于安全评估，不应自行停用长期处方药。

脑器质性或神经认知问题

突然出现的情绪或人格变化、明显意识混乱、新发神经体征或认知快速下降需要及时医学评估，以排查神经系统和其他身体原因。

正常悲伤与抑郁障碍

丧失后的悲伤可能强烈且反复，并不自动等于抑郁障碍；但悲伤与抑郁也可能并存。若痛苦持续、功能严重受损或出现安全风险，应寻求专业支持，而不是自行判断“只是悲伤”或“肯定是抑郁”。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：ICD-11 临床描述与诊断要求（CDDR）

5.1 药物治疗

> 本页是一般科普，不提供个人选药、剂量或疗程建议。药物应由具备资质的医疗人员根据诊断、病史、偏好、风险和既往反应共同决定。

常见药物类别

- **SSRI（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂）**：常见的一类抗抑郁药。
- **SNRI（5-羟色胺与去甲肾上腺素再摄取抑制剂）**：作用于相关神经递质系统，适用选择依个人情况。
- **NaSSA（去甲肾上腺素能和特异性 5-羟色胺能抗抑郁药）**：另一类药物，可能有不同的镇静、食欲或体重等影响。

药物类别不是“强弱排名”，同类药物也可能有不同的不良反应、相互作用和适应证。

起效与复诊

抗抑郁药一般不会像止痛药一样立即缓解情绪。部分人会先感觉睡眠、焦虑或其他症状变化，情绪改善可能需要数周；时间和反应因人而异。早期复诊可帮助评估副作用、风险和初步变化；若没有改善或症状恶化，应联系医生，而不是自行加量或频繁换药。

常见不良反应与需要报告的情况

初期可能出现恶心、头痛、睡眠变化、焦虑或胃肠不适等；也可能有性功能变化、体重变化或其他不适。副作用类型因药物而异，有些会随时间减轻，有些需要调整治疗。开始治疗或剂量变化后的情绪恶化、自伤想法增加、明显躁狂样变化或严重身体反应，应尽快告知医生；有迫切安全风险时立即求助急诊。

出现高热、意识混乱、明显激越、肌肉僵硬或抽动等严重症状时，需紧急医学评估，特别是同时使用多种影响血清素的药物时。

用药与停药原则

按处方使用，不与他人分享药物。突然停药或大幅减量可能引起停药症状或症状复发；若想停药、怀孕/哺乳、遇到副作用或忘记服药，应联系处方医生讨论个体化计划。忘服后的处理依药物而异，不要自行加倍补服。

相互作用与合并用药

开始任何处方药、非处方药、草药或补充剂前，告知医生或药师目前全部用药和物质使用情况。部分组合（例如某些抗抑郁药与单胺氧化酶抑制剂、其他影响血清素的药物或违禁物质）可能产生严重相互作用。不要自行混用、停药或用保健品替代正规治疗。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- National Institute of Mental Health：Depression

5.2 心理治疗

心理治疗是抑郁障碍治疗与康复的重要选择之一。适合的治疗方式取决于症状、既往经历、个人偏好、可及性和临床风险；治疗应由受过相应训练的专业人员实施。

认知行为疗法（CBT）

CBT 帮助患者观察情境、想法、情绪和行为之间的联系，识别可能维持痛苦的模式，并逐步练习更有帮助的应对方式。它不是要求患者“想积极一点”，而是通过合作和实际练习检验想法、恢复活动和解决问题。

正念认知疗法（MBCT）

MBCT 将正念练习与认知治疗元素结合，帮助患者识别情绪和反复思维，而不立即被其带走。它常被研究用于有复发经历的人群；是否适合、如何开展应与治疗人员讨论。正念不是压抑痛苦，也不能保证预防复发。

人际关系治疗（IPT）

IPT 关注人际关系变化、哀伤、角色转换和沟通困难与情绪之间的联系。它不假设所有抑郁都由关系问题造成，而是协助处理当下可工作的关系压力。

支持性心理治疗

支持性治疗可提供倾听、情绪支持、问题梳理和现实应对。患者可询问治疗目标、治疗者资质、隐私安排、费用、疗程和评估进展的方式。

如何选择治疗

轻度到较重抑郁的治疗选择需依据指南、症状和患者偏好共同决定；心理治疗、药物或两者结合都可能在不同情境中被考虑。不能简单规定所有中重度患者都必须采用同一种组合，也不能以心理治疗替代严重危机所需的医疗照护。

如果等待心理服务期间症状恶化，或出现自伤/自杀风险，应尽快联系医疗服务。治疗无效或难以坚持时，可与治疗人员讨论调整，而非认为自己“治疗失败”。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单

5.3 脑刺激等物理治疗

> 本页介绍需由专业团队评估和实施的治疗。适应证、设备、监管和可及性可能因地区不同；不应自行购买或接受未经规范评估的治疗。

电休克治疗（ECT）

ECT 是在麻醉、肌肉松弛和医疗监护下实施的医疗治疗。临床团队可能在严重抑郁、需要较快治疗反应、其他治疗反应不足，或患者既往对 ECT 有良好反应等情境下讨论其适用性。是否使用要结合风险、获益、替代方案和患者意愿，不应只凭某个症状自动决定。

ECT 可能带来短期困惑、头痛、肌肉酸痛或记忆方面影响；个体情况不同，需在治疗前后评估。患者有权询问麻醉与监护、疗程安排、可能的认知影响、替代方案和知情同意流程。通俗称呼“MECT”并不意味着它是没有麻醉或风险的简单操作。

重复经颅磁刺激（rTMS）

rTMS 使用线圈产生磁脉冲刺激特定脑区，通常不需全身麻醉。它可能适用于经专业评估后符合条件的人群，疗程和疗效因方案与个人而异。常见不适可能包括头皮不适或头痛，罕见但重要的风险及设备禁忌需由治疗团队说明。

其他脑刺激方式

其他神经调控方法可能在特定专科场景使用，证据、适应证、监管和可及性不一。网络宣传中所谓“脑刺激套餐”或“保证治愈”不能替代正规医疗评估。

决策前可询问

- 为什么建议这种治疗，目标是什么？
- 预期获益、常见和严重风险各是什么？
- 是否有药物、心理治疗或其他可替代方案？
- 如何评估疗效，若无效或不耐受怎么办？
- 治疗机构和人员是否具备相应资质？

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- NICE：Repetitive transcranial magnetic stimulation for depression
- American Psychiatric Association：The practice of ECT

1. 复发预警信号

> 预警信号是帮助尽早求助的个人变化，不是复发的自我诊断标准。单一变化也可能来自生活压力、身体疾病或药物影响。

可能值得留意的变化

- 睡眠时间、作息或早醒情况明显改变；
- 对平时喜欢的事兴趣下降，情绪持续走低或变得麻木；
- 体力、食欲、专注或完成日常任务的能力持续变差；
- 自责、无价值感、悲观或绝望想法增加；
- 社交和个人照护进一步减少；
- 药物副作用、漏服、停药或物质使用发生变化；
- 出现与以往发作相似的个人信号。

建立个人监测方法

可用简单日记记录睡眠、情绪、兴趣、精力、日常功能和压力事件，每天用几句话即可。避免反复打分、全天监控或把偶尔的坏心情视为复发。如果记录增加焦虑，可以减少频率或与医生商量更合适的方法。

预警后的行动

若变化持续、明显影响生活或逐渐加重，尽早联系治疗团队，回顾最近的压力、身体健康、治疗和支持安排。不要自行加药、减药或停药。

若出现自伤/自杀念头，尤其伴有计划、准备行为或无法保证安全，应立即告诉可信任的人并联系当地急救/急诊服务，而不是等待日记显示趋势。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单

2. 日常自我照顾策略

自我照顾不是“治好抑郁的唯一方法”，也不是要求患者靠意志解决疾病。症状严重时，完成基本生活任务都可能困难；从很小、可持续的步骤开始即可。

睡眠与作息

尽可能保持相对规律的起床时间和日间节奏，白天接触自然光并安排休息。睡眠困难时记录作息、咖啡因和药物变化，并与医生讨论；不要自行使用他人安眠药或大量饮酒助眠。

活动与运动

在身体允许且医生无特别限制时，可从短时间散步、伸展或日常活动开始，逐步增加。目标是支持身体和情绪健康，不以运动取代必要治疗；若活动后明显不适，应调整并咨询专业人员。

饮食和身体照护

尝试定时进食、补水和完成基本个人照护。食欲或体重明显变化、持续疼痛或胃肠症状应告诉医生，不能简单归因于抑郁。

社交与压力减负

维持一两个安全、低压力的联系即可，不必强迫参加大型社交。可以把任务拆小、推迟非紧急事项、请求具体帮助，并安排短暂休息。

简单情绪记录或正念

每天记录“今天的情绪/睡眠/完成的一件小事”，或做短时呼吸觉察，有助于观察模式。练习过程中若出现痛苦加重、创伤回忆或不适，可停止并寻求专业支持。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单

3. 负性思维觉察与调整

本页提供一个简化的自我观察练习，灵感来自认知行为治疗（CBT），不能替代由受训治疗人员提供的完整心理治疗。练习目的不是证明自己“想错了”，而是让思维更灵活、帮助选择下一步。

四步练习

1. **写下情境：**发生了什么？尽量写具体事实，而不是评价。
2. **记录想法和情绪：**当时脑中出现什么？情绪是什么、强度如何？
3. **检查证据：**支持这个想法的事实是什么？有没有遗漏的信息或其他解释？避免强迫自己找“积极证据”。
4. **形成平衡说法与小行动：**写一句更完整、不过度绝对的描述，再选择一个小而可行的行动。

示例

- 情境：朋友今天没有回复消息。
- 自动想法：“所有人都讨厌我。”
- 可核对事实：目前只有一条消息没回复；不知道对方是否忙碌。
- 更平衡的说法：“我现在担心被拒绝，但还没有足够信息判断关系。”
- 小行动：先做一件简单的日常任务，之后再决定是否联系朋友。

注意事项

如果练习变成反复分析、增加自责或引发强烈痛苦，可以暂停。抑郁会让负面判断显得特别可信；不需要独自说服自己。可把记录带给心理治疗师或医生一起讨论。

若出现自伤/自杀想法并有迫切风险，不要依靠此练习，立即联系可信任的人和当地急救/危机服务。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- NHS：Cognitive behavioural therapy (CBT)

4. 危机识别与急救

> 如果你此刻可能伤害自己，或无法保证自己安全，请马上联系身边可信任的人、当地急救/急诊服务；不要独自等待情况过去。本页不替代专业危机评估。

识别需要立即帮助的情况

自伤或自杀相关风险可能表现为反复想到死亡、表达绝望或不想活、出现具体计划或准备行为、已经自伤/尝试，或无法保证当下安全。风险会随时间变化；没有说出来不等于没有风险，量表分数也不能单独排除风险。

直接、平静地询问“你现在有没有想伤害自己或结束生命？”可以帮助打开求助对话。倾听时不要责备、羞辱、争辩或承诺替对方保密；应认真对待并协助联系专业人员。

迫切危险时怎么办

1. 联系所在地急救/急诊服务。在中国大陆，医疗急救可拨打 **120**；若现场存在现实的人身安全威胁，可联系 **110**。其他地区使用当地紧急号码。
2. 请可信任的人陪伴当事人前往急诊或等待救援；如果陪伴会使任何人处于危险中，先离开危险位置并联系急救。
3. 保持平静、简短沟通，减少围观和刺激；避免责骂、挑战或强行控制。
4. 在确保自身安全的前提下，暂时协助减少当事人接触可能造成伤害的物品；具体安全处理听从专业人员建议。
5. 向急救人员说明当前表现、已发生的行为、用药和相关健康情况。

不要只依赖网络问答、热线、家属承诺或等待预约处理迫切风险；不要让当事人独自承担危机。

可保存的个人安全计划模板

- **我的个人预警信号：**（睡眠、情绪、想法或行为变化）
- **我可以先尝试的安全应对：**（不会增加风险、可立即做到的活动）
- **能陪伴或联系我的人：**（姓名/联系方式；先征得对方同意）
- **我的治疗团队/就诊机构：**（工作时间与非工作时间联系方法）
- **最近的急诊或急救方式：**（地址、交通安排、当地紧急号码）
- **我希望支持者知道的事项：**（如何帮助、哪些做法会让我更难受）

安全计划应与专业人员共同制定、定期更新并妥善保存。若当前危险迫切，直接联系急救，不要花时间填写模板。

关于住院

是否需要住院由医疗团队结合当前危险、症状严重程度、基本生活能力、可用支持和当地法律程序评估。网络资料不能替代现场判断；必要时先到急诊接受评估。

参考来源

- 世界卫生组织：Suicide fact sheet
- 世界卫生组织：LIVE LIFE: an implementation guide for suicide prevention
- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

5. 社会支持

社会支持可以来自家人、朋友、同伴、医疗团队、学校/工作场所和社区服务。支持不等于替患者做所有决定；尊重自主、隐私和具体需要同样重要。

向亲友表达需求

可以选择相对合适的时间，直接说明“我最近在经历抑郁症状，想预约医生，希望你陪我去”或“我今天不需要建议，只希望你听我说十分钟”。请求越具体，亲友越容易知道如何帮忙。

可以分阶段分享信息，也可以说明哪些内容暂时不想讨论。若对方反应不佳，不代表痛苦不真实；可转向可信任的人、专业人员或支持服务。

亲友可以怎样支持

- 认真倾听并承认痛苦，不说“你就是想太多”；
- 提供实际、有限且可持续的帮助，例如陪诊、协助准备饭菜或一起散步；
- 鼓励联系专业服务，而不是强迫或羞辱；
- 若担心自伤风险，直接询问并协助尽快联系急救或治疗团队；
- 保护隐私，未经同意不向他人透露诊断和病史（紧急安全处置及法律要求除外）。

建立支持网络

在状态相对稳定时，可列出一位紧急联系人、一位能日常沟通的亲友、治疗团队和当地医疗求助渠道。不要让单一亲友承担所有照护和危机责任；支持者也需要休息和自己的支持。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services

1. 常见误区澄清

“想开点就好了”

倾听、陪伴和解决现实困难可能有帮助，但抑郁障碍不是靠劝说或意志就能控制。可说“我愿意陪你一起找帮助”，避免把康复责任变成患者是否足够努力的考验。

“抑郁就是矫情”

抑郁可能影响睡眠、食欲、精力、注意、决策和日常功能，是需要认真评估的健康问题，不是性格缺陷或寻求关注。外表正常也不代表没有痛苦。

“抗抑郁药会让人变傻或一定会上瘾”

抗抑郁药的作用和副作用因药物与个人而异。部分药物突然停用可能产生停药症状，这与成瘾概念并不相同。是否适用、有哪些风险及如何停药，应与开药医生讨论，不要因传言自行停药。

“症状好了就可以马上停药”

症状改善后仍可能需要巩固治疗或随访；是否减量、何时调整及怎样逐渐停药取决于病史和治疗反应。突然停药可能引起不适或症状复发，应先联系处方医生。

“有抑郁症就一定会自杀”

并非如此。但抑郁可能伴随自伤或自杀风险，若出现相关想法应认真评估并寻求帮助。风险不是由诊断名称决定，安全支持和及时治疗很重要。

“只要找到一个创伤，就找到病因”

抑郁通常涉及多种因素，不能简单归因于单一事件、家庭或个人性格。寻找支持和改善当前生活，比追究谁造成疾病更重要。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression（抑郁症）事实清单
- National Institute of Mental Health：Depression

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）

2. 生活与权益

> 本页为一般信息，不构成法律意见。病假、医保、残疾评定和热线服务会因地区、身份和政策变化，应向所在地主管部门核对现行规定。

就医与医疗信息隐私

患者可以询问医疗服务、费用、诊疗安排和个人信息如何保存或使用。诊断和病历属于敏感健康信息，不应被随意传播。是否向雇主、学校或亲友披露由个人结合实际需要决定；如担心披露后果，可先向正规法律或社会服务渠道咨询。

病假与工作学习安排

是否需要病假、休息或工作/学习安排调整，应由医疗评估和具体制度决定。可向医院、单位人事、学校辅导或当地劳动/教育服务了解证明要求和流程。诊断本身并不自动决定一个人不能工作或学习。

医保与社会支持

医保报销项目、心理服务可及性、医疗救助和康复支持因地区与参保类型而异。建议通过当地医保部门、卫生健康部门、医院社工或政府官方渠道查询最新政策，不依赖过期帖子。

残疾相关政策

是否符合残疾评定和相关服务资格需按现行标准、正式评估和地方流程办理；诊断不自动等同于取得残疾人证或某种补助资格。可向当地残联及主管部门咨询所需材料和复核/申诉渠道。

官方查询渠道

- 国家法律法规数据库：flk.npc.gov.cn
- 当地卫生健康、医保、人社、教育部门及残联的官方网站或窗口；
- 正规法律援助、劳动保障或社会工作服务。

办理前记录咨询日期、适用地区、经办部门和材料清单；政策有疑问时要求正式解释。

参考法律

- 《中华人民共和国个人信息保护法》
- 《中华人民共和国精神卫生法》
- 《中华人民共和国社会保险法》

以上法律及地方配套规定请以国家法律法规数据库和当地主管部门公布的现行文本为准。

3. 正规书籍与科普资源

选择科普读物时，优先考虑有明确作者/机构、出版年份、参考来源和适用读者说明的材料。医学内容可能更新，读书不能替代诊断、处方或危机评估。

推荐的公开资源入口

- **世界卫生组织（WHO）抑郁症事实清单：**基础定义、症状与公共卫生信息。阅读
- **WHO mhGAP 指南：**精神、神经和物质使用相关问题的循证服务框架。阅读
- **NICE 成人抑郁指南 NG222：**评估、治疗选择和随访建议；这是英国指南，应注意适用地区差异。阅读
- **美国国立精神卫生研究所（NIMH）抑郁资料：**面向公众的症状和治疗介绍。阅读
- **中国大陆正规医疗机构及专业学会发布的患者教育材料：**优先核对发布机构和发布日期。

选书与使用建议

可选择经过专业审阅的认知行为治疗、情绪管理或患者教育读物，优先使用书目由正规医院、大学或专业学会推荐的版本。自助书适合辅助学习，不适用于替代急诊、精神科评估或个体化治疗。

核验信息

记录作者或机构、书名/页面名、版次、出版年份、网址和访问日期。警惕没有证据、夸大“治愈率”、要求停药或兜售高价课程/保健品的内容。

参考来源

- WHO：Depression
- NICE：NG222
- NIMH：Depression

4. 偏方、保健品与网络“自愈疗法”风险

网络上常见“快速治愈”“无需就医”“天然无副作用”等宣传。情绪困扰时人容易急于寻找答案，但未经验证的方法可能延误评估、造成身体伤害或与处方药发生相互作用。

需要警惕的做法

- 宣称保证治愈、要求马上购买高价疗程或只接受某一种观点；
- 建议自行停抗抑郁药、替换处方或隐瞒医生使用的产品；
- 把保健品、草药、激素或“排毒”方案宣传成无需风险评估的治疗；
- 鼓励使用酒精、违禁物质或他人处方药缓解情绪；
- 要求公开个人病历、身份证明或隐私信息才能获得“疗效”。

保健品和草药

“天然”不等于安全。补充剂可能有药理作用、成分不确定、质量差异或与药物相互作用。开始、停止或更换任何补充剂前，先将产品名称和成分告诉医生或药师；尤其不要与抗抑郁药自行混用。

如何核验治疗宣传

查看是否有可核实的随机对照研究或可靠指南支持，研究对象是否与自己相似，是否公开风险和利益冲突，提供服务者是否具备相应资质。单个成功故事、网红推荐或销售页面不能证明疗效。

若已经尝试某种产品，不必因担心被责备而隐瞒；如出现不适，尽快联系医疗人员。不要突然停止处方药来“排毒”。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression
- 美国国立补充与综合健康中心：Using Dietary Supplements Wisely

共病专题：抑郁与其他健康问题

抑郁症状可能与其他精神或身体健康问题同时存在；共病评估有助于制定更适合的支持计划。出现一种问题并不意味着另一种必然存在。

焦虑障碍

持续担忧、惊恐、紧张或回避可能与抑郁共同出现。焦虑会影响睡眠和专注，也可能需要额外评估和治疗。

睡眠障碍

失眠、睡眠呼吸问题、昼夜节律改变或其他睡眠状况可能与情绪互相影响。长期睡眠差值得告知医生，而非仅依赖酒精或自行购买安眠药。

慢性疼痛与躯体症状

慢性疼痛和抑郁可能相互加重，患者的疼痛是真实的。评估可同时考虑身体和情绪因素，不应将所有疼痛归为“心理作用”。

物质使用问题

酒精或其他物质可能被用于短暂缓解痛苦，却可能进一步影响睡眠、情绪、判断和药物安全。若难以减少使用，应向医生或成瘾服务求助。

双相情感障碍鉴别

有抑郁发作不自动代表单相抑郁障碍。应向医生说明既往是否出现过持续的异常精力增加、睡眠需求减少、思维加速、话多、冲动或明显高涨/易怒时期。该信息可影响治疗安全；不要根据短期好转自行判断。

参考来源

- NICE：Depression in adults: treatment and management（NG222）
- 世界卫生组织：Depression

家属参考附录：陪伴与沟通

家属可以提供稳定支持，但不需要独自诊断或治疗患者。陪伴的目标是让患者感到被尊重，并协助其连接专业服务。

可以做的事

- 用开放、具体的问题倾听：“最近哪件事最难？”“你希望我怎么帮？”
- 承认感受：“听起来你承受了很多”，避免马上纠正或比较。
- 提供可选择的实际支持，如陪同预约、协助吃饭或分担一项任务。
- 鼓励正规评估，并尊重患者参与治疗决定的权利。
- 观察持续的睡眠、兴趣、功能和安全变化；以事实和关心表达担忧。
- 保护诊断与病史隐私，未经同意不向亲友或单位传播。

尽量避免

- “你就是想太多”“别人比你更惨”“振作起来”等否定或施压的话；
- 因患者状态变化而羞辱、威胁或惩罚；
- 未经医生意见替患者停药、加药或使用偏方；
- 承诺替患者保密自伤/自杀风险，或让家属独自承担危机照护。

危机时

若患者表达迫切自伤/自杀风险、已采取行动或无法保证安全，直接联系当地急救/急诊服务；在中国大陆医疗急救可拨 **120**，现场存在现实人身安全威胁时可拨 **110**。如安全可行，请可信任的人陪伴，并减少围观和刺激。

家属也需要支持

照护者可以寻求医生、医院社工、正规家属支持服务或心理咨询；安排休息和轮替照护并非放弃患者。支持应在患者同意、隐私和安全框架内进行。

参考来源

- 世界卫生组织：Depression

- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- 世界卫生组织：Suicide prevention

康复者视角

本专题可收录当事人的康复经历、应对方式和对服务的感受，帮助读者看到个体化的恢复路径。每篇内容须清楚注明：**这是个人经验，不代表所有患者，也不是诊断或治疗建议。**

建议的访谈范围

- 当事人希望分享的经历和不希望公开的部分；
- 哪些支持或环境调整对其有帮助；
- 曾遇到的困难，以及目前仍需要的支持；
- 对就医、治疗沟通和社会污名的个人感受；
- 希望读者理解的一件事。

不要求讲述创伤细节、药物剂量或自伤方法；避免把故事包装成“只要做到某件事就能康复”的模板。

知情同意与隐私

发布前明确用途、读者范围、署名方式、是否可撤回以及可能传播范围。删除可识别的个人或第三方信息；不得未经同意公开病历、照片或家庭细节。访谈者应允许受访者跳过问题或随时停止。

参考原则

- 世界卫生组织：Guidance on community mental health services
- 世界卫生组织：Depression